HELP_Organi_P12 — Groupe C — Lots 232 à 236 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 12 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

C-001 — Haute — LOT 232 · SSP O7.10 ; O7.11 ; O7.12 ; O7.13

Emplacement : LOT_232_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 232 Plan et Liste › un devoir professionnel (lacune #0) ; LOT 232 Plan et Liste › un devoir professionnel (lacune #1) ; LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 › devoir professionnel d'informer (lacune #6) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Sources (lacune #43) ; LOT 233 Plan et Liste › I.A. Définir le refus de traitement › directives de l’ASSM (lacune #0) ; LOT 233 Plan et Liste › Sources (lacune #16) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › 🔍 Fenêtre Interactive 3.3 : Devoir d’informer et de documenter (lacune #33) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #37) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › Sources (lacune #38) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Non-discrimination (code de déontologie FMH) (lacune #76) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › CP 122, 123 et 181 (lacune #78) ; LOT 234 Plan et

Liste › Bloc 1 — Monographie du SSP › 🔍 Fenêtre Interactive 12.6 : Secret médical et information des partena (lacune #1) ; LOT 234 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (situation de › Cadre légal : déclaration, secret médical et remboursement (lacune #10) ; LOT 234 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (situation de › Cadre légal : déclaration clinique et de laboratoire, secret, rembours (lacune #12) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) › secret professionnel et information des partenaires (lacune #34) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #54) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #57) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S4] (lacune #2) ; LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #16) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › Lacunes restantes (lacune #57)

Contexte : Le cours cite l'art. 10 (devoir d'informer), les art. 4 al. 3 et 5 (non-discrimination) du Code de déontologie FMH et les directives FMCH « Informations aux patients » du 9.5.2019, uniquement via le guide ASSM/FMH 2020 ; le texte intégral du Code (version 2025) n'a pas été lu.

Question : Quel est le texte en vigueur du Code de déontologie de la FMH (version, date d'entrée en vigueur, URL) pour les articles sur l'information du patient, le consentement, le dossier médical, le secret médical, la non-discrimination et l'information des partenaires d'un patient atteint d'IST ? Les directives FMCH « Informations aux patients » de 2019 sont-elles toujours en vigueur, et que prescrivent-elles (délai de réflexion, forme écrite, documentation) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-002 — Haute — LOT 232 · SSP O7.10 ; O7.11 ; O7.14

Emplacement : LOT_232_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 232 Plan et Liste › MacCAT-T (lacune #4) ; LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 (lacune #10) ; LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 › MacCAT-T (lacune #13) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #23) ; LOT 232 Partie 3 DX.6 a DX.7 › MacCAT-T (lacune #28) ; LOT 233 Plan et Liste › II.C. Les outils d’évaluation (lacune #3) ; LOT 233 Plan et Liste › VI.a. Gold standard (lacune #12) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #25) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #34) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #45) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › MacCAT-T et U-Doc (lacune #47) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #56) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #92) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Tableau d'interprétation des outils d'évaluation et d'entretien (lacune #93) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Évaluation de la capacité (gold standard clinique) (lacune #108) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #37)

Contexte : Le cours décrit l'évaluation de la capacité de discernement selon la directive ASSM 2019 (quatre capacités, évaluation approfondie de 10 à 90 minutes, MacCAT-T, U-Doc de l'Université de Zurich) ; il écrit qu'aucun seuil, sensibilité ou spécificité n'est connu, y compris chez le mineur et pour le suicide assisté.

Question : La directive ASSM « Évaluation de la capacité de discernement » (2019) a-t-elle été révisée ? Quels sont les seuils de score publiés du MacCAT-T (et de ses sous-échelles) et leurs valeurs de sensibilité et de spécificité ? L'U-Doc a-t-il une version validée en Suisse ? Existe-t-il un outil validé chez le mineur et une recommandation suisse sur l'âge indicatif de la capacité de discernement pour un traitement ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-007 — Haute — LOT 232 · SSP O7.10

Emplacement : LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #15) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #16) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #17)

Contexte : Le cours expose l'urgence vitale sans capacité de consentir (CC 379, directive anticipée, ordonnance d'urgence médicale, renonciation à la réanimation) ; le délai d'information a posteriori du patient et des représentants n'est pas chiffré.

Question : Que disent le CC 379 et la directive ASSM « Mesures de réanimation » (version la plus récente) sur l'information a posteriori du patient ou du représentant après un traitement d'urgence, sur la validité de l'ordonnance d'urgence médicale (ex. formulaire « ordonnance médicale d'urgence », OFSP/palliative ch) et sur la documentation d'une renonciation à la réanimation ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-011 — Haute — LOT 232 · SSP O7.10 ; O7.11

Emplacement : LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 › trouble psychique, déficience mentale, grave état d'abandon (lacune #35) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Cantons : traitement ambulatoire sous contrainte (lacune #37) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 › encéphalopathie, intoxication (lacune #38) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #39) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › grave état d’abandon (lacune #43)

Contexte : Le cours cite le CC 426 (trouble psychique, déficience mentale, grave état d'abandon) sans définition clinique ni seuil ; le traitement ambulatoire sous contrainte relève du droit cantonal, non lu.

Question : Comment la doctrine et la jurisprudence fédérale définissent-elles « trouble psychique », « déficience mentale » et « grave état d'abandon » au sens du CC 426 ? Quels cantons (dont Neuchâtel, Vaud, Genève) prévoient un traitement ambulatoire sous contrainte et des mesures ambulatoires (CC 437), avec la base légale cantonale et son URL ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-003 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10 ; O7.13

Emplacement : LOT_232_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 232 Plan et Liste (lacune #5) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #19) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #20) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #21) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › interprétariat communautaire (lacune #1) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Cst. art. 8 al. 2 (lacune #4) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S4] (lacune #13) ; LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #17) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › financement de l'interprétariat (lacune #25) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › cinq outils (lacune #26) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › cinq outils (lacune #27) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S112] (lacune #28) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #29) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S4] (lacune #31) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S4] (lacune #32)

Contexte : Le cours s'appuie sur les recommandations de la CNE (2017) et sur des données INTERPRET de 2017 : financement non assuré, variable selon les cantons, absence de position tarifaire ambulatoire, interprétariat téléphonique 24 h/24 en 30 langues, vidéo en projet pilote ; aucun outil standardisé de vérification de la compréhension (restitution).

Question : Quel est en 2026 le financement de l'interprétariat communautaire en Suisse (position TARDOC ou autre tarif ambulatoire, financement stationnaire, financement cantonal, notamment Neuchâtel) ? Quelles sont les statistiques récentes d'utilisation (INTERPRET, OFSP) et la disponibilité actuelle de l'interprétariat téléphonique et vidéo ? Existe-t-il une recommandation suisse sur la méthode de restitution (teach-back) pour vérifier la compréhension d'un consentement ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-004 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10 ; O7.11

Emplacement : LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 (lacune #12) ; LOT 232 Partie 3 DX.6 a DX.7 › donnée non trouvée (lacune #27) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #36) ; LOT 233 Plan et Liste › I.B. Mesurer l'ampleur en Suisse › directives de l'ASSM (lacune #1) ; LOT 233 Plan et Liste › I.B. Mesurer l'ampleur en Suisse › 🔍 Fenêtre Interactive I.1 : Chiffres suisses et européens du refus de (lacune #2) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #20) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 2.1 : chiffres suisses des PAFA (Obsan, données (lacune #41)

Contexte : Le cours cite les PAFA 2016 (Obsan) : 14 580 personnes, 1,7/1000, Vaud 3,31/1000, 52 % d'hommes, troubles organiques F0 n = 1343 ; l'erratum Obsan de juin 2019 signale des données inexactes ; le nombre de traitements sans consentement n'est pas connu.

Question : Quels sont les chiffres suisses les plus récents (Obsan, OFS) des placements à des fins d'assistance et des mesures ou traitements sans consentement (CC 434), avec année, taux pour 1000 habitants, répartition cantonale et diagnostique, et URL ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-005 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10 ; O7.11

Emplacement : LOT_232_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 232 Plan et Liste (lacune #2) ; LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 › données non disponibles (lacune #7) ; LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 › données non disponibles (lacune #8) ; LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 › données non disponibles (lacune #9) ; LOT 232 Partie 3 DX.6 a DX.7 › donnée non trouvée (lacune #26) ; LOT 232 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #29) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #31) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › 🔍 Fenêtre Interactive 2.1 : Repères chiffrés : lecture critique (lacune #32) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 › APEA (lacune #91) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) (lacune #97) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › femme enceinte capable de discernement (lacune #105) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Pourquoi aucun chiffre n'est extrapolé (lacune #106) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) (lacune #111)

Contexte : Le cours écrit qu'aucune source ne chiffre en Suisse les litiges pour défaut d'information (bureau d'expertises extrajudiciaires FMH), les plaintes pénales après geste médical, les extensions peropératoires, ni la fréquence des refus de traitement chez l'adulte capable, le mineur et la femme enceinte.

Question : Existe-t-il des données suisses publiées (rapports annuels du bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH, assureurs RC, études suisses) sur les litiges pour défaut d'information, les refus de traitement par des adultes capables, des mineurs ou des femmes enceintes, et les extensions peropératoires ? Donne les chiffres, l'année et l'URL ; à défaut, la meilleure donnée européenne. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-006 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10

Emplacement : LOT_232_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 232 Plan et Liste (lacune #3) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 › thérapie expérimentale dans le cadre individuel (lacune #40) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #41) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #42)

Contexte : Le cours cite la Convention d'Oviedo (art. 5, 6, 8) et la LRH ; l'art. 17 d'Oviedo (recherche sur des personnes incapables de consentir) n'a pas été lu ; le nombre de projets autorisés par les commissions d'éthique et l'évolution 2026 de la LRH/ORH ne sont pas connus ; le cadre de la thérapie expérimentale individuelle repose sur le seul guide ASSM/FMH.

Question : Que prévoient l'art. 17 de la Convention d'Oviedo et les art. 21 à 24 LRH sur la recherche avec des personnes incapables de discernement et en situation d'urgence ? La révision de l'ORH/OClin entrée en vigueur en 2024 et une révision LRH en cours changent-elles le consentement ? Combien de projets swissethics a-t-il autorisés la dernière année publiée ? Quelle règle suisse encadre l'essai thérapeutique individuel (usage compassionnel, art. 9b LPTh) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-008 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10

Emplacement : LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 232 Partie 1 DX.1 a DX.2 › planification anticipée (ACP) (lacune #14) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 › planification anticipée de la santé (lacune #18)

Contexte : Le cours cite la planification anticipée concernant la santé (ACP) et la cohorte Lc65+ : la moitié des 71–80 ans ignore ces dispositions ; aucun essai n'a été retrouvé.

Question : Quel est le cadre national suisse actuel de la planification anticipée concernant la santé (feuille de route OFSP/palliative ch, version et année), et quelles données suisses récentes existent sur la fréquence des directives anticipées et l'efficacité de l'ACP ? Donne la recommandation suisse

en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-009 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10

Emplacement : LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #22) ; LOT 232 Partie 2 DX.3 a DX.5 (lacune #24)

Contexte : Le cours indique que la majorité est fixée à 18 ans (CC 13–14), que les droits strictement personnels s'exercent dès la capacité de discernement et que le droit de décision passe progressivement des parents à l'adolescent (ASSM) ; la fréquence des conflits parents-équipe n'est pas connue.

Question : Quelle recommandation suisse (ASSM, Société suisse de pédiatrie, Pédiatrie suisse) fixe la conduite du consentement chez le mineur capable ou incapable de discernement, y compris en cas de conflit parents-équipe et de refus d'un traitement vital (saisie de l'APEA) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-010 — Moyenne — LOT 232 · SSP O7.10

Emplacement : LOT_232_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #32) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #33) ; LOT 232 Partie 4 DX.8 a DX.10 (lacune #34)

Contexte : Le cours traite les gestes à exigence particulière : IVG (CP 119–120, OFS 2025 : 12 048 IVG, 7,2/1000), stérilisation, don vivant, analyse génétique, chirurgie esthétique ; les effectifs et la jurisprudence esthétique ne sont pas connus.

Question : Quelles exigences de consentement fixent la loi sur la stérilisation, la loi sur la transplantation (don vivant) et la LAGH (version révisée en vigueur depuis 2022) ? Existe-t-il une jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'information en chirurgie esthétique ? Quels sont les effectifs suisses récents des stérilisations, dons vivants et analyses génétiques ? Y a-t-il une modification législative en 2025–2026 sur l'IVG ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-012 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 233 Plan et Liste › VIII.D. Pronostic, évolution et recherche en 2026 › 🔍 Fenêtre Interactive VIII.6 : Évolution sociétale et normative en 202 (lacune #14) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › mesure de contrainte (lacune #18) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 11.D.1 : évolution observée et état normatif 202 (lacune #51) ; LOT 233 Partie 3 DX.6 a DX.7 (lacune #95)

Contexte : Le cours utilise un résumé (PHC 2018) de la directive ASSM « Mesures de contrainte en médecine » (2015) ; la révision est en cours (atelier public du 22.5.2025) ; le texte intégral n'a pas été lu.

Question : Quel est le statut en 2026 de la directive ASSM « Mesures de contrainte en médecine » (version 2015 ou version révisée, date, URL) ? Quelles conditions fixe-t-elle pour la contrainte, la documentation et la contention, et quelles différences apporte la nouvelle version ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-013 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Plan et Liste › VIII.D. Pronostic, évolution et recherche en 2026 › 🔍 Fenêtre Interactive VIII.6 : Évolution sociétale et normative en 202 (lacune #15) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 3.4 : CP 114–115 et assistance au suicide (lacune #65) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #68) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 11.D.1 : état normatif 2026 et lacunes (lacune #73)

Contexte : Le cours cite la directive ASSM « Attitude face à la fin de vie et à la mort » 2018 (critère de souffrance insupportable), le refus de la FMH de l'intégrer (renvoi à la version 2004) et l'exigence d'une expertise psychiatrique (TF 2006) ; la version révisée 2021/2022 n'a pas été lue.

Question : Quelle est la version en vigueur de la directive ASSM sur la fin de vie et l'assistance au suicide (version 2021/2022, conditions exactes, deux entretiens à deux semaines d'intervalle, cas de la souffrance sans maladie grave) ? La FMH l'a-t-elle intégrée à son Code ? Quelles sont les conditions de l'expertise psychiatrique selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la plus récente ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-014 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11 ; O7.14

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #19) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › Attention (lacune #22) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › Apathie (lacune #23) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.2 : Dépister le délirium : CAM, 4AT, mCAM-ED, (lacune #26) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.2 : Dépister le délirium : CAM, 4AT, mCAM-ED, (lacune #27) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) (lacune #30) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › délire (lacune #71) ; LOT 236 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › délire (lacune #72)

Contexte : Le cours décrit le dépistage du délirium (test des mois à rebours, mCAM-ED, CAM, 4AT ≈ 2 minutes, DOS 13 critères) et cite des recommandations suisses (délirium 11–25 % à l'admission des > 65 ans) ; les seuils, la prévalence suisse mesurée et les critères de résolution manquent.

Question : Quels sont les seuils de positivité du 4AT, de la DOS, de la CAM et du mCAM-ED, leurs sensibilités et spécificités, et les critères diagnostiques DSM-5-TR/CIM-11 du délirium ? Quelle recommandation suisse (SSG/SPSG, Felix Platter, CHUV, HUG) fixe le dépistage, la prise en charge et le critère de résolution du délirium, y compris en soins intensifs (CAM-ICU, ICDSC) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-015 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Plan et Liste › III.A. Hypothèses fréquentes et graves › Coma (lacune #4) ; LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › Conscience (lacune #24) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › trouble de la conscience (lacune #54) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Situation de coma (lacune #116)

Contexte : Le cours décrit le trouble de la conscience (de la somnolence au coma) sans échelle chiffrée.

Question : Quelles échelles de conscience les sources suisses et européennes recommandent-elles (Glasgow Coma Scale avec seuils de gravité, FOUR, AVPU, RASS) et quelle interprétation chiffrée en donnent-elles pour l'évaluation d'un patient qui semble refuser un soin ? Donne la recommandation

suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-016 — Haute — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11, PROFILES 2023) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.3 : Bilan de la cause : examen, valeur, seuil, (lacune #28) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #42) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #44) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › hypoglycémie (lacune #52) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #53) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #55) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.b.1 : examens de première intention, tableau d (lacune #57) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.b.1 : examens de première intention, tableau d (lacune #58)

Contexte : Le bilan d'une cause organique chez le patient qui refuse (signes vitaux, glycémie capillaire, CRP, TSH, alcoolémie) renvoie aux « valeurs de référence du service » ; le seuil d'hypoglycémie et le seuil légal d'alcoolémie ne sont pas chiffrés ; l'OMS est citée pour l'alcoolémie (> 1,5 g/L stupeur).

Question : Quels seuils chiffrés retenir pour l'hypoglycémie (niveaux 1–3, mmol/L, selon SSED/ADA-EASD), les signes vitaux d'alarme (NEWS2 ou score utilisé en Suisse), et quels examens de laboratoire minimaux recommandent les sources suisses devant une confusion aiguë ? Quels sont les seuils d'alcoolémie de la LCR/OAC et la corrélation clinique alcoolémie-sévérité en g/kg (‰) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P12 — 16 questions : C-001, C-002, C-007, C-011, C-003, C-004, C-005, C-006, C-008, C-009, C-010, C-012, C-013, C-014, C-015, C-016